

Fecha Última Actualización: 26-08-2022 23:00:50

Página 1 de 5

Información Paciente

Nombre : Eugenio Hernan Moreno Castillo

Rut : 9.257.076-2

N° Archivo : 0608294

N° Epicrisis

320731

Edad : 61a 6m 3d

Fecha Nacto: 23/02/1961

Sexo : Masculino

Dirección : Wolney Quiroga 2570 Poblacion Colonia E

Comuna : Puente Alto

Teléfono : 9 5822 6756

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 06/08/2022 12:05

Días Estadía : 20

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 26/08/2022 23:08

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Fiebre, No Especificada

Comorbilidades

Diabetes Mellitus 2; Hipertensión Arterial; TVP;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Laparotomía Exploradora, C/S Liberación De Adherencias, C/S Drenaje, C/S Biopsias Como Proc. Aut. O Como Resultado De Una Herida Penetrante Abdominal No Complicada O De Un Hemoperitoneo Postoperatorio O Como Tratamiento De Una Peritonitis (Laparostomía .. - 24/08/2022 18:45 - Juan Pablo Ramos Perkis

Diagnostico Enfermedad Arterial Oclusiva De Extremidades - 22/08/2022 20:00 - Maria Berenice Garcia Gimenez

Emolizaciones De Malformaciones Vasculares Y Otras Terapias Enovascuales Cerebrales (Exceptua Trat. Endovascular Del Anuerisma) - 22/08/2022 20:00 - Maria Berenice Garcia Gimenez

Epidemiologia

Resumen Clínico

Egreso UCI

Nombre: Eugenio Moreno Castillo.

RUT: 9257076-2

Edad: 61 años

Fecha Ingreso HSR: 05/08/2022.

FI UTIM 1°: 09/08/2022.

FI sala básica: 13/08/2022.

FI UTIM 2°: 19/08/2022

FI UCI: 22/08/2022

FE UCI: 26/08/2022

Anamnesis remota

- Médicos: DM2 usuario de insulina con DOB (nefropatía y retinopatía proliferante), HTA, ERC etapa II, TVP en TACO desde julio de 2022

- Quirúrgicos: Catarata ODI.

- Fármacos: Lantus 54 + apidra, metformina 850 mg c/12 hrs, empaglifozina 12.5 mg, enalapril 20 mg c/12 hrs, amlodipino 10 mg al día, atorvastatina 40 mg al día, aspirina 100 mg al día.

- Alergias: no tiene.

- Hábitos: niega tabaco, OH y drogas

- Inmunizaciones: COVID x 3.

- Hospitalizaciones recientes: no tiene.

Anamnesis próxima

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 23:00

Página 1 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:44

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 26-08-2022 23:00:50

Página 2 de 5

Cuadro de 3 días de compromiso del estado general y pérdida de fuerza en 4 extremidades. Ingresó en regulares condiciones generales, hemodinamia estable, febril hasta 38°C, sin requerimientos de oxígeno.

Al examen físico destacaba bien perfundido, neurológico con bradipsiquia y rigidez de nuca, resto normal.

Se solicitó un TAC de cerebro que mostró infartos subagudos de la corona radiada derecha y prefrontales izquierdas en territorio límite. Aterosclerosis intracraneal difusa.

Dado INR alterado no se pudo realizar punción lumbar. Se decidió inicio empírico de antibióticos para una posible meningitis vs endocarditis por hallazgos de ACV obs embólicos.

Laboratorio de ingreso: Na 134, K 3.83, Cl 96, Crea 1.49, BUN 32.7, Hb 11.9, leucocitos 16880, RAN 13000, plaquetas 428000, PCR 298.7, INR 3.23.

Se intentó RNM stroke, frustra por no colaboración.

Se solicitó evaluación por UCO para posible endocarditis. Ecografía bedside realizada por el Dr. Alegría sin signos de endocarditis en esa modalidad.

En estas condiciones ingresa para estudio y manejo en UTIM - Sala básica.

Diagnósticos de ingreso

Síndrome febril en estudio.

Síndrome confusional en estudio.

AKI KDIGO I

EVOLUCIÓN:

Hemodinamia: A su ingreso con HDN estable. El 19/08 evoluciona con hipotensión, por lo que se inicia volemicación y NAD, y se traslada a unidad monitorizada. En contexto de shock hemorrágico se realiza AngioTAC 21/08 ¿Extenso hematoma retroperitoneal izquierdo con focos de sangrado activo principalmente en relación al músculo psoas¿, se realiza transfusión de GR y plasma fresco congelado, y se contacta a radiología intervencional para resolución en pabellón. Evoluciona con requerimiento de NAD con dosis altas y adrenalina.

Respiratorio: A su ingreso sin conflicto de lo respiratorio. El 21/08 evoluciona con paro respiratorio, por lo que se intuba.

Infectológico: Síndrome febril sin foco identificado, con soplo sistólico de tiempo de evolución desconocida y TAC de cerebro con infartos subagudos con sospecha de embolia. Se inicia ceftriaxona, ampicilina y gentamicina de forma empírica por sospecha de endocarditis.

Estudio microbiológico:

- 06.08 : PCR SARS COV 2 (-) UC (-) HMC 1 y 2 periféricos negativos.

- 09.08: LCR con bioquímica normal. Gram sin bacterias, cultivo negativo a las 72 horas. PCR HS I, HS 2 y VVZ negativo, VDRL en LCR no reactivo.

HMC I y II negativos.

- 16.08: HMC I y II negativos.

- 18.08: VDRL en suero y MHA-TP pendiente en sistema.

- 19.08 : HMC I y II negativos a la fecha.

Estudio de imágenes:

- 09/08 TAC de abdomen y pelvis: Sin evidencia de foco infeccioso

- 17/08: Ecocardiograma TT sin evidencia de endocarditis infecciosa. Insuficiencia mitral leve. FEVI 62%.

- 22/08: Extenso hematoma retroperitoneal izquierdo con focos de sangrado activo principalmente en relación al músculo psoas. Leve hemoperitoneo. Áreas corticales hipodensas de menor impregnación en ambos riñones con características de focos de nefritis, que pueden corresponder a áreas de hipoperfusión dado contexto clínico.

Moderado derrame pleural izquierdo con atelectasia subtotal del LII

-(P) Cintigrama óseo y fondo de ojo.

El 19.08 evoluciona con shock séptico, fiebre e hipotensión, con necesidad de reanimación con cristaloides y noradrenalina en dosis bajas. Se toman nuevos HMCs periféricos el 19/08 y 20/08 los cuales se mantienen negativos a la fecha y se cambia esquema antibiótico a meropenem + vancomicina.

Neurológico: Conocido por equipo de neurología por compromiso de conciencia multifactorial. Con evolución favorable durante hospitalización hasta hoy 19.08.2022 9:00 hrs con cuadro de déficit neurológico súbito, acompañado de PAM 57 mmHg que se maneja con volumen y NAD. Se activa protocolo stroke, NIHSS 25. TAC-angioTC: ASPECT 8 (ACM derecha). Suboclusión de A1 y M2 proximal derecha y M2 distal

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 23:00

Página 2 de 5

Fecha Última Actualización: 26-08-2022 23:00:50

Página 3 de 5

izquierda, obs trombo rojo. Ateromatosis bulbo carotídeo derecha sin estenosis significativa. Con contraindicación absoluta para trombolisis dado a anticoagulación con HBPM por TVP y con indicación de trombectomía mecánica. Se presenta caso al equipo de endovascular, a la espera de respuesta. Se realiza RNM de cerebro (19/08) ¿Infarto lacunar antiguo del cuerpo estriado derecho. Microangiopatía confluyente de sustancia blanca supratentorial. Signos de leve dña difusa de volumen encefálico, sin un patrón característico. Estenosis multifocal menor a 50% de arterias intracraneanas de predominio en segmentos A1 y P2/P3, probablemente ateromatosa. Se inician medidas de neuroprotección y levetiracetam. Se realiza EEG que evidencia disfunción lenta continúa generalizada reactiva. Evaluado por neurología decide mantener levetiracetam.

Renal: Ingresa con AKI KDIGO I (Crea basal 07/22 0.82), la que resuelve con volemicización. Evoluciona con falla multiorgánica secundaria a shock hemorrágico con Crea 4.52 al momento del traslado, hipocalcemia con BIC de calcio e hipernatremia 150.

Metabólico: antecedente de diabetes mellitus tipo 2, usuario de insulina. Se mantiene con indicación de insulina basal y esquema correccional.

ETE: Paciente con antecedente de TVP en julio/2022. Se reinicia anticoagulación tras realización de PL. Tras shock y caída de Hb se suspende anticoagulación.

Debido a gravedad de paciente, en manejo con NAD 0.4 mcg/Kg/min + Adrenalina 0.25 mcg/Kg/min, y necesidad de intubación, se decide traslado a UCI.

Evolución en UCI

Hemodinamia: Paciente cursando con shock séptico + hemorrágico, persiste con requerimiento de 2 DVA (Noradrenalina y Adrenalina), con PAM protectora de presión de perfusión abdominal. Post pabellón, se logra suspender adrenalina y se aumenta NAD a dosis intermedias, con disminución leve de FC manteniéndose normocárdico. Mal perfundido, aunque mejor que días previos. Posterior a pabellón se transfunde con GR y PFC, sin impresionar con nuevo sangrado. Evoluciona con vasoplejía severa, requiriendo incremento de NAD y reinicio de EPI.

Respiratorio: Paciente con requerimientos de VMI se mantiene con parámetros protectores. Se disminuye FR por pH 7.45. Mejoría leve de PaFi a 240. Evoluciona con SDRA con difícil manejo, requiriendo incremento de FIO2 hasta 100%

Infeccioso: Paciente con shock séptico de foco desconocido con parámetros inflamatorios estacionario, afebril en las últimas 24 horas. HC 16/08 negativo, HC 19/08, 20/18, 23/08 negativo a la fecha, cultivo traqueal 22/08 coco gram (+), UC (-), cultivo corriente intraoperatorio negativo a la fecha. Laparoscopia exploradora describen intestino sin signos de isquemia. Pendiente ecocardiograma transesofágico. Se mantiene meropenem + vancomicina (FI 19/08), vancomicina niveles supratrapéuticos por lo que suspendido hasta 26/08.

Gastrointestinal: Miércoles 24.08 se realiza laparoscopia exploradora donde se evidencia líquido serohemático 2-3 Lts, hematoma retroperitoneal sin nuevo sangrado. Se instala bolsa de bogotá, por lo que se decide suspender bloqueo neuromuscular.

Renal: Cursando con falla renal AKI KDIGO 3 probablemente secundario a shock y HIA. Última diálisis 23/08, actualmente sin urgencia dialítica.

Neurológico: Se mantiene en ASA 1 dado hipertensión abdominal con fentanil + midazolam. En manejo con levetiracetam indicado por neurología.

Nutrición: Dado indemnidad de intestino se inicia nutrición enteral conversado con nutrición.

ETE: Paciente con antecedente de TVP julio/2022 se revisa en sistema TVP infrapoplitea anticoagulado por síntomas. Actualmente anticoagulación suspendida por sangrado reciente. Se planteó filtro vena cava inferior, sin embargo dado gravedad del paciente y bajo riesgo de TEP dado que TVP es infrapoplitea, se mantiene suspendida planteamiento hasta mayor estabilidad.

Presenta evolución tórpida durante últimas 18 horas, mal perfundido con DVA (NAD y adrenalina) al alza, taquicárdico, con

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 23:00

Página 3 de 5

Fecha Última Actualización: 26-08-2022 23:00:50

Página 4 de 5

difícil ventilación y PaFi en disminución, alteración de las pruebas de coagulación y acidosis metabólica. Además con mal pronóstico desde el punto de vista neurológico.

Se decide en conjunto con equipo médico limitación del esfuerzo terapéutico. Se avisará a familiares sobre mal pronóstico y decisión de limitación. Paciente fallece a las 22:28hrs. Se avisa a Familiares

Diagnósticos de Egreso

Shock Mixto Refractaria

- Shock Séptico de foco no precisado
- Shock Hipovolemico sec a Sangrado
- Paro respiratorio recuperado (22-08 am)
- Hematoma retroperitoneal izquierdo - Embolización arteria ileo lumbar 22/08
- Hipertensión intraabdominal - Bolsa de bogota 24/08
- CID
- Acidosis Metabólica
- SDRA
- Falla Renal Aguda
- Falla Hepática Aguda
- Disfunción miocárdica por sepsis
- Vasoplejia refractaria
- SOFA 18
- Sd febril en estudio
- Obs PNA bilateral?
- ACV isquémico territorio de ACM D° obs cardioembólico
- DM2- HTA
- TVP Izquierda

Diagnóstico de Egreso

- Shock Séptico Sin Foco -
- Shock Hemorrágico - Hematoma Retroperitoneal
- Insuficiencia respiratoria aguda -
- Accidente vascular isquémico -
- Choque hipovolémico - Shock Mixto Refractaria
- Shock Séptico de foco no precisado
- Shock Hipovolemico sec a Sangrado
- Paro respiratorio recuperado (22-08 am)
- Hematoma retroperitoneal izquierdo - Embolización arteria ileo lumbar 22/08
- Hipertensión intraabdominal - Bolsa de bogota 24/08
- CID
- Acidosis Metabólica
- SDRA
- Falla Renal Aguda
- Falla Hepática Aguda
- Disfunción miocárdica por sepsis
- Vasoplejia refractaria
- SOFA 18
- Sd febril en estudio
- Obs PNA bilateral?
- ACV isquémico territorio de ACM D° obs cardioembólico
- DM2- HTA
- TVP Izquierda

Condición de Egreso Fallecido

fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

Fecha Epicrisis : 26/08/2022 23:00

Página 4 de 5

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:44

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

fallecido

Indicaciones

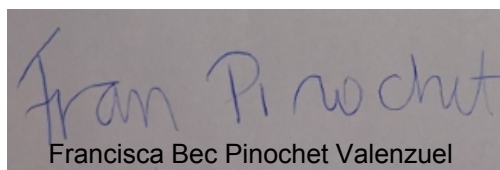
Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Francisca Bec Pinochet Valenzuel

Becado/Residente



Gonzalo Núñez Muñoz

Médico Tratante (Staff)